

TEMA 9.65 • RESPIRATORIO

Prick Test

PERFIL EUNACOM 1.04.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Prick Test**, también conocido como test de puntura cutánea, es la herramienta diagnóstica de elección para identificar la **sensibilización mediada por IgE** frente a diversos alérgenos. Es una prueba fundamental en el estudio de patologías como la **Rinitis Alérgica**, el **Asma** bronquial y las alergias alimentarias.

¿Qué evalúa el Prick Test?

Su objetivo principal es demostrar la presencia de **sensibilización**. Es fundamental entender que una prueba positiva no equivale automáticamente a una alergia clínica; la interpretación siempre debe realizarse en el contexto de la historia del paciente.

- Se utiliza para testear diferentes categorías de alérgenos:
- **Alérgenos respiratorios (Aeroalérgenos):** Ácaros del polvo, pólenes (gramíneas, malezas, árboles), epitelios de animales (perro, gato) y hongos.
- **Alérgenos alimentarios:** Leche de vaca, huevo, frutos secos, pescados, mariscos, legumbres, entre otros.
- **Alérgenos de exposición laboral:** Látex, harinas, enzimas industriales.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El Prick Test reproduce a pequeña escala una reacción de hipersensibilidad tipo I (inmediata). Al introducir el alérgeno en la epidermis, este interactúa con la IgE específica unida a la superficie de los **mastocitos** cutáneos. Si hay sensibilización, el mastocito se degranula liberando histamina y otros mediadores que provocan vasodilatación y edema local (la "roncha").

Técnica del Procedimiento

El procedimiento es mínimamente invasivo y se realiza generalmente en la cara anterior del antebrazo.

- **Limpieza:** Se limpia la piel con alcohol o agua.
- **Marcación:** Se marcan los puntos donde se aplicarán las gotas de los extractos alérgenos, dejando una separación de al menos 2 cm entre cada uno para evitar la coalescencia de reacciones.
- **Aplicación de gotas:** Se coloca una gota de cada extracto, incluyendo siempre los controles.
- **Puntura (Lanceta):** Con una lanceta estéril o aguja fina, se realiza una mínima escoriación epidérmica a través de la gota. Es crucial **no producir sangrado** y cambiar el dispositivo (o limpiar meticulosamente) entre cada alérgeno para evitar la contaminación cruzada.
- **Espera:** Se deja actuar por un periodo de **15 a 20 minutos**.
- **Lectura:** Se mide el diámetro de la pápula (roncha) resultante.

Interpretación de los Resultados

Para que la prueba sea válida, los controles deben funcionar correctamente.

Criterio de Positividad

Se considera que un paciente está **sensibilizado** a un alérgeno si: - El control positivo es adecuado. - El control negativo es negativo. - El alérgeno produce una **roncha con un diámetro mayor o igual a 3 milímetros**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: El Prick Test detecta **sensibilización**, no necesariamente enfermedad. El diagnóstico de "Alergia" es **clínico**. Si el test es positivo pero el paciente no presenta síntomas al exponerse al alérgeno, se dice que está sensibilizado pero no es alérgico.

Limitaciones y Consideraciones

Existen factores que pueden alterar el resultado, llevando a falsos negativos o situaciones de riesgo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Interferencia Farmacológica: Los **antihistamínicos** (H1) deben suspenderse al menos 3 a 7 días antes de la prueba, ya que bloquean la respuesta de la histamina y pueden dar falsos negativos. Otros fármacos como antidepresivos tricíclicos también pueden interferir.

- **Edad:** En lactantes muy pequeños o ancianos, la reactividad cutánea puede estar disminuida.
- **Estado de la piel:** No se debe realizar en zonas con eccema activo, dermatografismo severo o quemaduras solares.
- **Riesgo de Anafilaxia:** Aunque es extremadamente raro con la técnica de prick (a diferencia de las pruebas intradérmicas), siempre debe realizarse en un entorno médico que cuente con equipo de reanimación y adrenalina disponible.

Resumen de Utilidad Clínica

- **Asma y Rinitis Alérgica:** Identifica los gatillantes ambientales para guiar medidas de control ambiental y evaluar la posibilidad de inmunoterapia (vacunas de alergia). - **Alergia Alimentaria:** Ayuda a identificar el alimento sospechoso, aunque a menudo requiere confirmación con pruebas de provocación oral si la clínica es dudosa. - **Seguimiento:** Permite evaluar si un paciente ha desarrollado tolerancia espontánea (común en alergias alimentarias infantiles).

NOTA CLÍNICA

Si un paciente tiene una historia clínica muy sugerente de alergia pero el Prick Test es negativo, se puede solicitar una **IgE específica en sangre** (ImmunoCAP) para complementar el estudio.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Se realiza un prick test a un paciente con sospecha de rinitis alérgica. El control con histamina no produce roncha y el control con suero fisiológico tampoco. Los alérgenos testeados no muestran reacción. ¿Como se interpreta este resultado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prick Test. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

TABLA 9.65.1: ELEMENTO VS SUSTANCIA

ELEMENTO	SUSTANCIA	RESULTADO ESPERADO	UTILIDAD
Control Positivo	Histamina (10 mg/ml)	Roncha $\geq$ 3 mm	Confirma que la piel es reactiva y que no hay fármacos interfiriendo.
Control Negativo	Suero Fisiológico	Roncha de 0 mm	Asegura que el paciente no presenta dermatografismo (reacción por el roce).
Alérgenos	Extractos específicos	Variable	Evalúa la sensibilización específica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El prick test evalúa sensibilización a alérgenos, NO hace diagnóstico de alergia (el diagnóstico es clínico)
- Los alérgenos testeados dependen de la sospecha: respiratorios, alimentarios o laborales
- Se colocan gotas con alérgenos en el antebrazo y se realiza una mínima escoriación epidérmica
- Control positivo: histamina (debe hacer roncha para validar el examen)
- Control negativo: suero fisiológico (no debe hacer roncha para descartar dermatografismo)
- Resultado positivo: roncha de 3 mm o más de diámetro
- El prick test confirma sensibilización, que debe correlacionarse con la clínica para diagnosticar alergia

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PRICK TEST)**PREGUNTA 1**

Se realiza un prick test a un paciente con sospecha de rinitis alérgica. El control con histamina no produce roncha y el control con suero fisiológico tampoco. Los alérgenos testeados no muestran reacción. ¿Cómo se interpreta este resultado?

- A)** El paciente no está sensibilizado a ninguno de los alérgenos testeados
- B)** El examen no es válido porque el control positivo (histamina) debió producir roncha
- C)** Confirma diagnóstico de rinitis no alérgica
- D)** El paciente probablemente tiene dermatografismo
- E)** Se debe repetir el examen con alérgenos diferentes

PREGUNTA 2

Un paciente con rinorrea crónica se realiza un prick test. El control positivo (histamina) produce una roncha de 5 mm. El control negativo (suero fisiológico) produce una roncha de 4 mm. Varios alérgenos muestran ronchas de 4-5 mm. ¿Cómo se interpreta este resultado?

- A)** El paciente está sensibilizado a múltiples alérgenos; tiene rinitis alérgica severa
- B)** El examen no es válido porque el control negativo no debió producir roncha, sugiriendo dermatografismo
- C)** El paciente tiene una reacción alérgica generalizada que requiere tratamiento urgente
- D)** Los resultados son normales y descartan causa alérgica
- E)** Se deben considerar positivos solo los alérgenos con roncha mayor a 5 mm

PREGUNTA 3

Un paciente con prick test positivo para acaro del polvo (roncha de 5 mm) pero que niega síntomas respiratorios al estar en su casa ni en ningún otro ambiente. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A)** Tiene rinitis alérgica asintomática y debe iniciar tratamiento preventivo
- B)** El prick test es un falso positivo y debe repetirse
- C)** Está sensibilizado al acaro pero no tiene enfermedad alérgica clínica; el diagnóstico de alergia es clínico
- D)** Tiene alergia subdiagnosticada y requiere inmunoterapia
- E)** Debe realizarse IgE específica sérica para confirmar la alergia

RESUMEN: PRICK TEST

Esta clase explica el prick test (test cutáneo), un examen fundamental en alergología que evalúa la sensibilización a distintos alérgenos. Los alérgenos testeados dependen de la sospecha clínica: pueden ser respiratorios (rinitis, asma), alimentarios o de exposición laboral. El procedimiento consiste en colocar gotas con diferentes alérgenos sobre la piel del antebrazo y realizar una mínima escoriación epidérmica con una aguja o lanceta (que se cambia para cada alérgeno). Se incluyen siempre dos controles: un control positivo con histamina (que debe producir una roncha, confirmando que la piel reacciona adecuadamente) y un control negativo con suero fisiológico (que no debe producir roncha, descartando dermatografismo). La lectura se realiza a los 15-20 minutos. Un resultado se considera positivo cuando la roncha mide 3 milímetros o más de diámetro. Es fundamental entender que el prick test no diagnostica la alergia en sí (ya que este es un diagnóstico clínico), sino que confirma la sensibilización a un alérgeno específico. Un paciente puede estar sensibilizado pero no tener síntomas clínicos, por lo que siempre se debe correlacionar con la clínica.